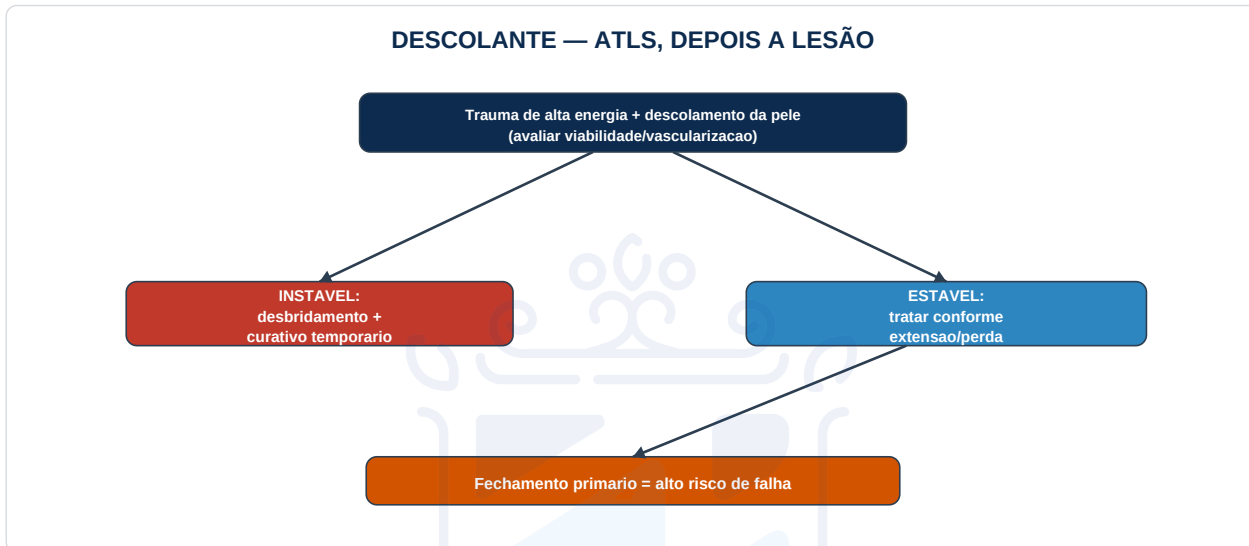


FERIMENTO DESCOLANTE — CISALHAMENTO DA PELE

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Trauma de ALTA energia -> cisalhamento da pele -> descolamento dos planos profundos
- Compromete a vascularização arterial e/ou venosa do retalho cutâneo (risco de necrose)
- Fechamento PRIMÁRIO tem ALTO risco de falha (a pele descolada frequentemente não é viável)
- Localização mais comum: MEMBROS INFERIORES (~90%)

APRESENTAÇÃO

RECONHECER

- Extensão e perda cutânea VARIÁVEIS
- Tipicamente POUCO sangramento (engana sobre a gravidade)
- Pode ser ISOLADO ou ASSOCIADO a outras lesões (fraturas, trauma de alta energia)
- Descolante OCULTO (lesão de Morel-Lavallée): coleção entre o subcutâneo e a fáscia, sem ferida aberta
- Avaliar a viabilidade do retalho (cor, sangramento de bordas, temperatura)

TRATAMENTO — POR CENÁRIO

Rx CONDUTA

Sempre 1o o ATLS (descolante é de alta energia e pode haver lesões associadas)

Paciente INSTÁVEL: desbridamento + curativo temporário (controle de dano); fechamento primário nem sempre é a melhor opção

Morel-Lavallée PEQUENO: conservador — esvaziamento por punção + curativos compressivos

EXTENSO ou com perda tecidual: cirurgia — desbridamento, drenagem/aspiração, enxertia, retalho, escleroterapia

Profilaxia antitetânica; analgesia; antibiótico conforme contaminação

RED FLAGS / CUIDADOS

ATENÇÃO

- Não subestimar pelo pouco sangramento — a área desvascularizada pode evoluir para necrose extensa
- Avaliar e tratar lesões associadas (fraturas, neurovasculares) — alta energia
- Síndrome compartimental e infecção são complicações a vigiar
- Fechamento primário sob tensão de retalho não viável = falha e necrose
- Encaminhar à cirurgia plástica/ortopedia/cirurgia conforme extensão e estruturas envolvidas

CONDUTA NO PS

PASSOS

- ☐ ATLS + buscar lesões associadas; controlar hemorragia
- ☐ Avaliar extensão, perda cutânea e viabilidade do retalho
- ☐ Instável: desbridamento + curativo temporário (damage control)
- ☐ Morel-Lavallée pequeno: punção + compressivo; extenso/perda: cirurgia (desbridamento/enxerto/retalho)
- ☐ Antitetânica, analgesia, antibiótico se contaminado; encaminhar especialista

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Ferimento descolante por ____ (alta energia), localização ____ (MMII?), extensão/perda ____.
- Viabilidade do retalho: ____; lesões associadas (fraturas/neurovasculares): ____.
- Conduta: desbridamento + curativo temporário / punção (Morel-Lavallée) / enxerto-retalho.
- Antitetânica feita. Solicito avaliação de cirurgia plástica/ortopedia (estabilizar antes).

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Sobre o fechamento primário no ferimento descolante extenso, é correto:

- A) É sempre a melhor opção
- B) Tem ALTO risco de falha, pois a pele descolada frequentemente não é viável
- C) Elimina a necessidade de desbridamento
- D) Está indicado mesmo em retalho inviável
- E) Não há risco de necrose

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a localização mais comum do ferimento descolante?

- A) Membros superiores
- B) Membros inferiores (~90%)
- C) Couro cabeludo
- D) Tórax
- E) Abdome

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

A lesão de Morel-Lavallée corresponde a:

- A) Fratura exposta
- B) Descolante OCULTO (coleção entre subcutâneo e fáscia, sem ferida aberta)
- C) Queimadura de 3o grau
- D) Hematoma intracraniano
- E) Lesão de víscera oca

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Lesão de Morel-Lavallée pequena. Qual a conduta conservadora?

- A) Desbridamento cirúrgico amplo imediato
- B) Esvaziamento por punção e curativos compressivos
- C) Apenas observação sem intervenção
- D) Enxertia imediata
- E) Amputação

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Por que o ferimento descolante pode ser subestimado no atendimento inicial?

- A) Porque sempre sangra muito
- B) Porque costuma sangrar pouco, mascarando a gravidade e o risco de necrose da área desvascularizada
- C) Porque não se associa a outras lesões
- D) Porque nunca evolui com necrose
- E) Porque é sempre superficial

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

No descolante extenso, o fechamento primário tem alto risco de falha porque a pele descolada perdeu a vascularização e frequentemente não é viável, evoluindo para necrose. Avalia-se a viabilidade e prefere-se desbridamento/enxerto/retalho.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Os membros inferiores são a localização mais comum (~90%) do ferimento descolante, geralmente por mecanismos de alta energia com cisalhamento (ex.: atropelamento).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A lesão de Morel-Lavallée é o descolante OCULTO: uma coleção (linfa/sangue) entre o tecido subcutâneo e a fáscia muscular, sem solução de continuidade da pele.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Morel-Lavallée pequeno pode ser tratado conservadoramente com esvaziamento por punção e curativos compressivos; coleções extensas ou com perda tecidual exigem abordagem cirúrgica.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O descolante costuma sangrar pouco, o que mascara a gravidade; a área desvascularizada pode evoluir para necrose extensa, e há lesões associadas (alta energia) — por isso não deve ser subestimado.

SM24
Suporte ao Plantão Médico